

כל הזכויות שמורות

מחלקת בטחון
מועצה אזורית הר חברון

מחלות לב וכלי דם

Acute Coronary Syndromes

1

כל הזכויות שמורות

מחלקת בטחון
מועצה אזורית הר חברון

טרשת עורקים

טרשת עורקים = תהליך בו מצטברים משקעי סידן ושומנים על דפנות כלי הדם וגורמים להצרתם וחסימתם.

עורק תקין

עורק טרשתי

2

כל הזכויות שמורות

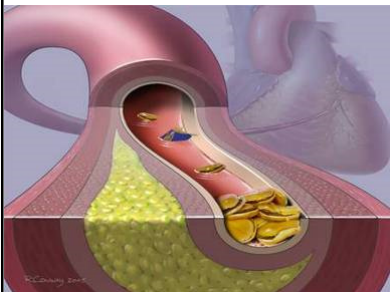
טרשת עורקים

מחלקת בטחון
מועצה אזורית הר חברון

התהליך מתקיים בכל כלי הדם בגוף ואצל כל אדם באוכלוסיה אך קצב ההתקדמות של התהליך הינו שונה מאדם לאדם.

גורמים המשפיעים על קצב ההתקדמות:

- ★ תורשה.
- ★ מין - גברים יותר.
- ★ עישון.
- ★ תזונה.
- ★ מתח נפשי.
- ★ פעילות גופנית.



3

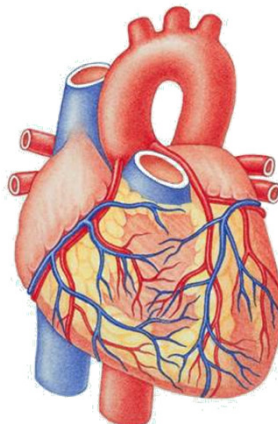
כל הזכויות שמורות

טרשת עורקים

מחלקת בטחון
מועצה אזורית הר חברון

שריר הלב מקבל את אספקת הדם והחמצן שלו מרשת כלי דם המכונים כלי דם כליליים (קורונריים).

הצרות משמעותית של העורקים הכליליים עקב טרשת עורקים תגרום להפרעה באספקת החמצן לשריר הלב.

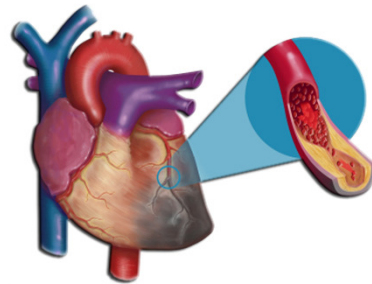


4

תעוקת לב / חזה

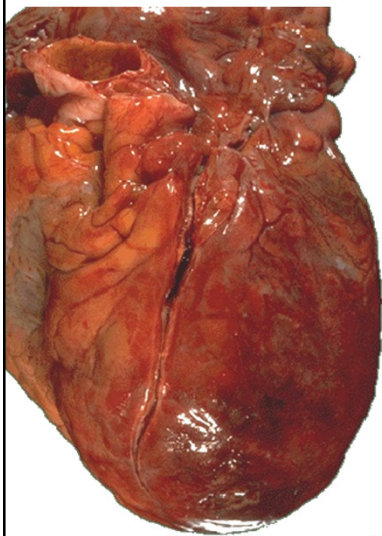
במצב של מאמץ או התרגשות בו קיימת עליה
בצריכת החמצן של הלב עלולה הצרות זו
לגרום למחסור חמצן בשריר הלב
הנקרא תעוקת לב / חזה (אנגינה פקטוריס).

תעוקה זו חולפת בדרך-כלל
לאחר מנוחה של מספר
דקות או טיפול תרופתי.



5

אוטם בשריר הלב



חסימה מוחלטת של אחד
העורקים הכליליים עקב
התגברות טרשת העורקים או
יצירת קריש דם תגרום להפסקה
מוחלטת באספקת הדם לאזור
מסוים בשריר הלב שיעבור
בתוך מספר שעות נמק.
חסימה זו נקראת אוטם בשריר
הלב (התקף לב).

6

כל הזכויות שמורות

אוטם בשריר הלב

סימני מחסור באספקת דם לשריר הלב:

- ★ כאב (לוחץ) בחזה.
- ★ הקרנת כאב לכיוונים שונים.
- ★ קשיי נשימה.
- ★ בחילות, הקאות וצרבות.
- ★ חיוורון.
- ★ זיעה קרה.
- ★ חרדת מוות.







7

כל הזכויות שמורות

אוטם בשריר הלב

זיהוי אוטם בשריר הלב:

1. קליניקה של החולה המלווה בסימנים ותסמינים
2. תרשים אק"ג המדגים אוטם / איסכמיה חריפה
3. אנזימים ספציפיים (מרקרים קרדיאליים) חיוביים

בבדיקת אנזימים בדם



8

כל הזכויות שמורות

אוטם בשריר הלב

הסכנה העיקרית באירוע לב היא הפסקת פעילות הלב (דום לב) כתוצאה מהפגיעה בשריר הלב.





טיפול באירוע לב:

- ★ הרגעת ומניעת מאמץ פיזי
- ★ שקול מתן חמצן.
- ★ תן אספרין בלעיסה
- ★ שקול מתן ניטרטים

9

כל הזכויות שמורות

גישה לטיפול עם כאב בחזה ממקור לבבי





אגף רפואה
ינואר 2016

אוגדן
לצוות BLS



חשד להסכנת כליות חריפה

גישה כללית לטיפול חולה

בצע אומנזה בדקה נטפית מסוגת

הושב את המטופל במידת האפשר

ודא כי המטופל נמצא במנחה חלשה

שקול מתן חמצן

שקול מתן אספירין בלעיסה

שקול סיוע בתוך ניטרטים תת לשוני

פנה בדחיפות להגעה/הקוב"ה הקרוב

המשך כיסוי וטיפול במהלך הפינוי

שקול התברר דיווח מקדים להקד"מ/הק"מ

דגשים:

אזהרה:

- תעד במידת האפשר את מנגד הפעולות הסיסטמטיות.
- שאל על מחלות רקע גורמי סיכון – סוכרת, יתר לחץ דם, יתר שומנים בדם, עישון, פרופור פיזיולוגיים.
- איזון מים בבער, מחלת לב איסכמית, מחלת כלי דם פרפרית.
- טיפול תרופתי קבוע – בדגש על אספירין, ניטרטים צגודי קרישה.

הערה:

- במידה המטופל מראה סימנים של מחלה נשימתית (מחנק, סינפוזיאט, שימוש בשאירי עזר, רטרקציות, וכו').

הערה:

- צורת מתן – בלעיסה.
- מינון – 160-325 mg.
- ודא התווית נגד טרם מתן.

ניטרטים:

- סיוע לטיפול הנוסל בקביעות לפי הוראת רופא.
- צורת מתן – תת לשוני.
- מינון – עד 2 מנה בהפרש של 2-3 דקות בין המנות.
- יש להודיע לר"ב בצג מתן ניטרטים (להימנע מתתן במידה להר"ב נטון).
- יש להימנע מתתן ניטרטים לטיפול נטון תרופות לטיפול באין-אנזכ ב 36 השעות האחרונות.

10

אספירין

ייתן מרמת חובש ומעלה, או לאחר קבלת הוראה ממוקד מד"א.

מתן בלעיסה – 300 מ"ג.

(אצטוסל, קרטיה, מיקרופירין, טבעפירין, גורמד)



חובה לשלול רגישות / אלרגיה לתרופה

חובה לשלול גורמי סיכון:

• כיב פעיל

• דימום פעיל

• טראומה או ניתוח בימים האחרונים

• הריון – משנה זהירות ! (התרופה מזיקה לעובר)

11

ניטרטים

ייתן לחולה הנוטל בקביעות בלבד.

חובה לשלול רגישות / אלרגיה לתרופה



חובה לשלול נטילת תרופות

לאין-אונות ב 36 שעות האחרונות.

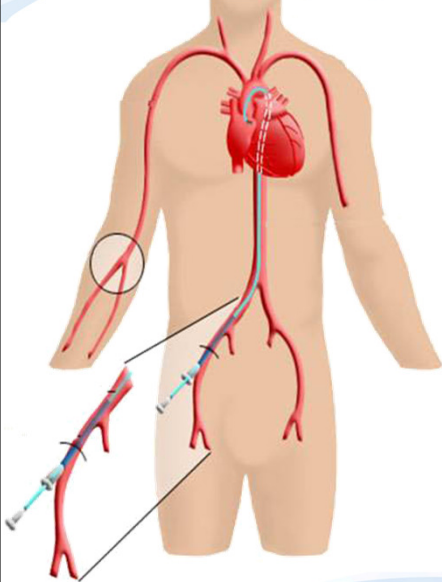
• מדידת ל"ד לפני ואחרי. לא מתחת ל 100 סיסטולי.

12

כל הזכויות שמורות

מחלקת בטחון
מועצה אזורית הר חברון

צינטור - PCI



צינטור הינו החדרת צינורית אל אבי-העורקים עד ללב.

בעזרת הזרקת חומר דרך הצינורית ישירות אל עורקי הלב וביצוע במקביל סדרת צילומי רנטגן ניתן לזהות את העורקים המוצרים והחסומים.

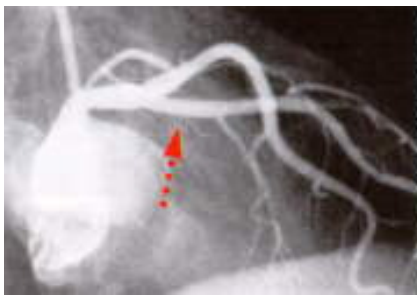
13

כל הזכויות שמורות

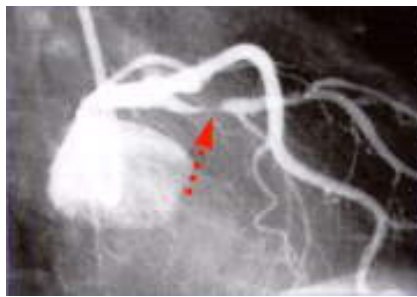
מחלקת בטחון
מועצה אזורית הר חברון

צינטור

עורק תקין



עורק עם הצרות



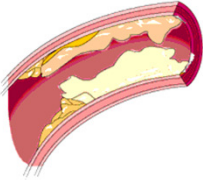
14

כל הזכויות שמורות

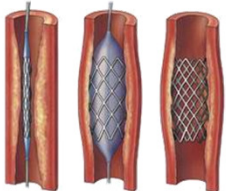
מחלקת בטחון
מועצה אזורית הר חברון

צינטור

במקרה בו במהלך הצינטור מזהים הצרות או חסימה ניתן לבצע בעזרת הצינורית שממוקמת בלב גם פתיחה / הרחבה של העורק.



★ הרחבה על-ידי בלון.



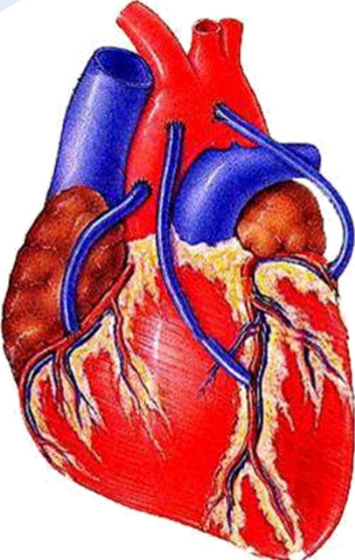
★ הרחבה על-ידי קפיץ.

15

כל הזכויות שמורות

מחלקת בטחון
מועצה אזורית הר חברון

מעקפים - CABG



במקרה בו במהלך הצנטור מזהים חסימה במספר עורקים שונים ניתן לבצע ניתוח מעקפים. במהלך הניתוח מחברים כלי-דם מאבי-העורקים ישירות אל העורק החסום ועוקפים את החסימה.

16